BOLETIM DE RESULTADOS

Estudo I



Saúde do trabalhador

e a covid-19

GPST
Grupo de Pesquisa Subjetividade e Trabalho
CNPq
MINISTÉRIO DA SAÚDE
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
PÁTRIA AMADA BRASIL
GOVERNO FEDERAL

Thaís Augusta de Oliveira Máximo
Tatiana de Lucena Torres
Adson Cunha
Marcus Carvalho
(Coordenadores)

BOLETIM DE RESULTADOS

Estudo I



Saúde do trabalhador e a covid-19

Boletim de resultados do Estudo I é uma publicação do projeto
Saúde do trabalhador e a covid-19

Núcleo de Comunicação
Coordenação e edição de texto: Suéllen Rodrigues
Projeto gráfico e arte: Gabrielly Nascimento

COORDENAÇÃO GERAL

COORDENADORA
Thaís Máximo

VICE-COORDENADORA
Tatiana Torres

COORDENADOR DE TI
Adson Cunha

COORDENADOR DE TI
Marcus Carvalho

ASSISTENTES

ASSESSOR DE PESQUISA
E ANÁLISE DE DADOS
Linniker Moura

ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
Ulisses Nascimento

ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO
Suéllen Rodrigues

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA
E PESQUISA DE CAMPO
Valéria Nicolau

LÍDER TÉCNICO DO
NÚCLEO DE TI
Walterlly Nicolau de Sousa

BOLSISTAS DE GRADUAÇÃO

CONSTRUÇÃO DOS
INSTRUMENTOS E MAPEAMENTO
DAS REDES DE SINDICATOS
DE PROFISSIONAIS
Maria Beatriz Medeiros
e Wesley Silva

CONSTRUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E
INSTRUMENTOS DE PESQUISA
Daniely Santana

DESENVOLVIMENTO BACK-
END WEB E MOBILE
Arthur Cavalcante

DESENVOLVIMENTO FRONT-
END WEB E MOBILE
Kawhan Laurindo

DESIGN DE INTERFACES
WEB E MOBILE
Relbert Medeiros

LEVANTAMENTO SISTEMÁTICO
DA LITERATURA E MATERIAL
DOCUMENTAL SOBRE A COVID-19
Maria Luiza Lopes e Rian Enedino

MAPEAMENTO DE REDE DE
ASSISTÊNCIA E ATENDIMENTO
À COVID-19 NO NORDESTE
Eduarda Dias, Lígia Ferraz
e Lucas Vasconcelos

MÍDIAS DIGITAIS
Gabrielly Nascimento

APRESENTAÇÃO

Este boletim apresenta resultados iniciais das análises exploratórias do banco de dados coletado para o primeiro estudo do projeto “A saúde dos trabalhadores da saúde no contexto da pandemia da covid-19: prevenção e cuidado” (Universidade Federal da Paraíba/CNPq). Temos o intuito de caracterizar o perfil socioeconômico, laboral e de comportamento durante a pandemia de covid-19 dos/as trabalhadores/as participantes.

O Estudo I, aplicado remotamente, por meio de questionário on-line, entre os meses de novembro de 2020 e fevereiro de 2021, teve como público-alvo trabalhadores da saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) com atuação no enfrentamento à covid-19 em estados da região Nordeste.



DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS QUANTO AO PERFIL SOCIOECONÔMICO

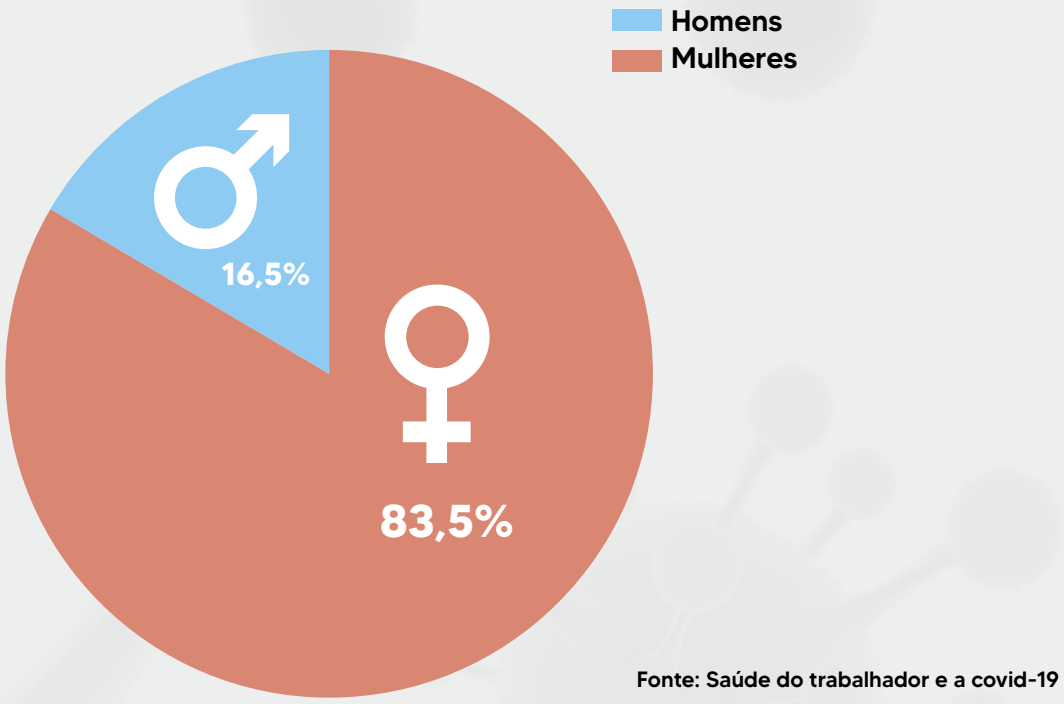
No Gráfico 1, é possível observar que os participantes apresentaram grande diversidade de enquadramentos funcionais e profissões (vinte e três), sendo maioria de Enfermagem (28%). Também importa destacar os/as trabalhadores/as que acumulam mais de uma função (3,2%), uma prática recorrente entre os/as profissionais da saúde.

Gráfico 1. Profissão



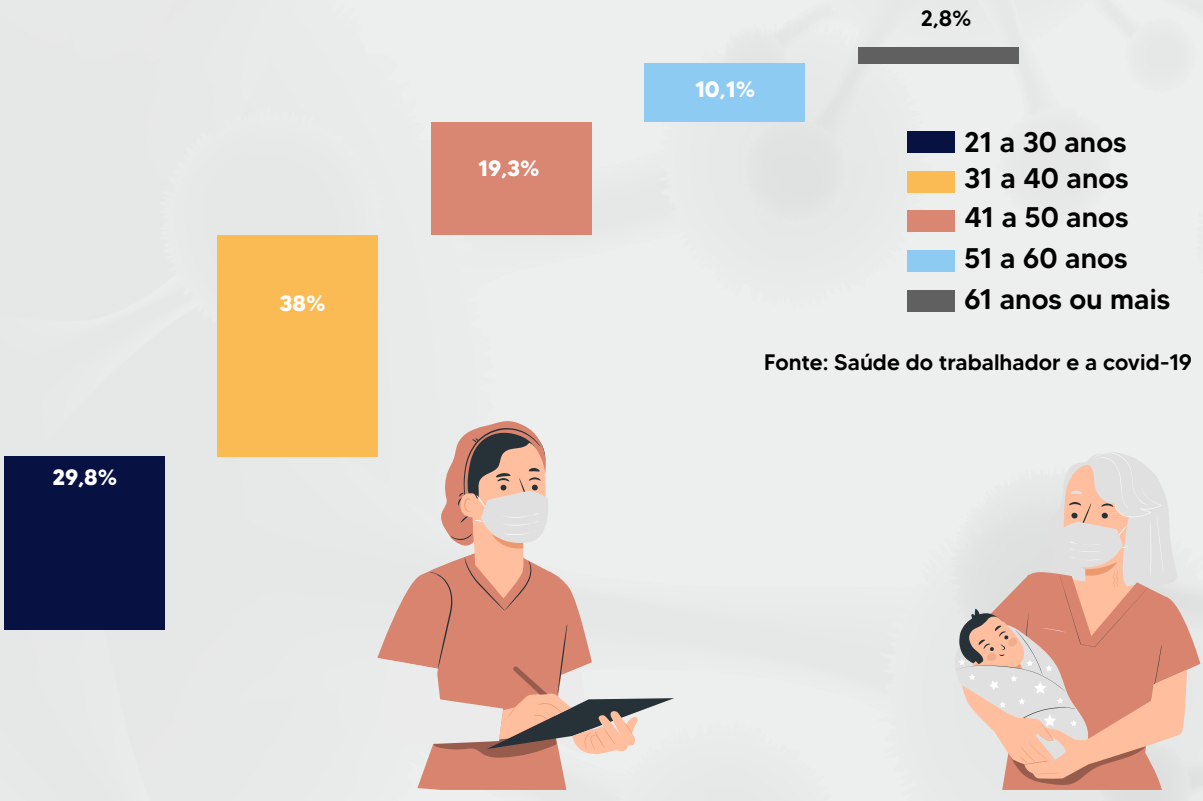
A amostra foi formada majoritariamente por pessoas do sexo feminino (83,5%) [Gráfico 2] e, quanto à idade, a maioria dos/as profissionais se encontra na faixa dos 21 aos 50 anos (87,1%) [Gráfico 3]. Sobre a cor de pele, houve predominância das cores parda (49,5%) e branca (36,7%), o que indica também uma tendência encontrada em pesquisas mais recentes entre os/as trabalhadores/as da saúde, onde uma porcentagem menor é de outras cores/raças [Gráfico 4].

Gráfico 2. Gênero



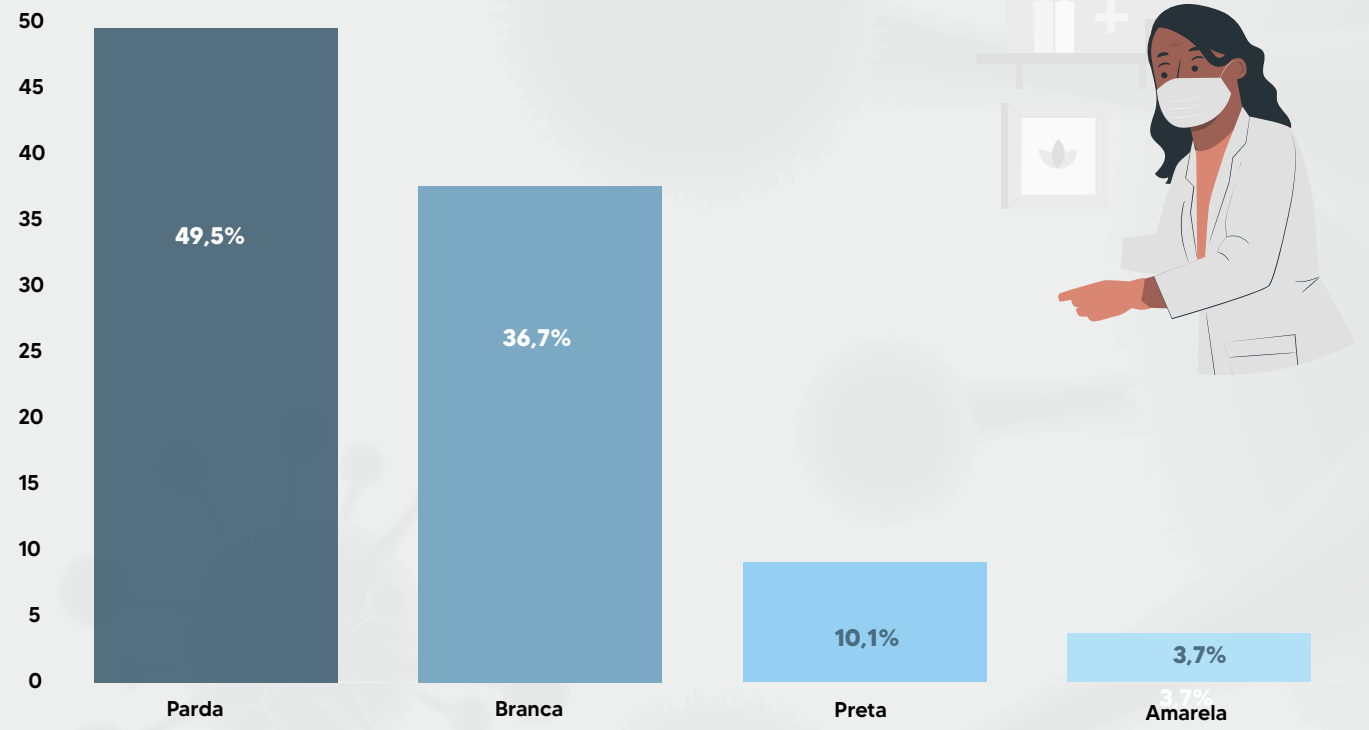
Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

Gráfico 3. Idade



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

Gráfico 4. Cor/raça

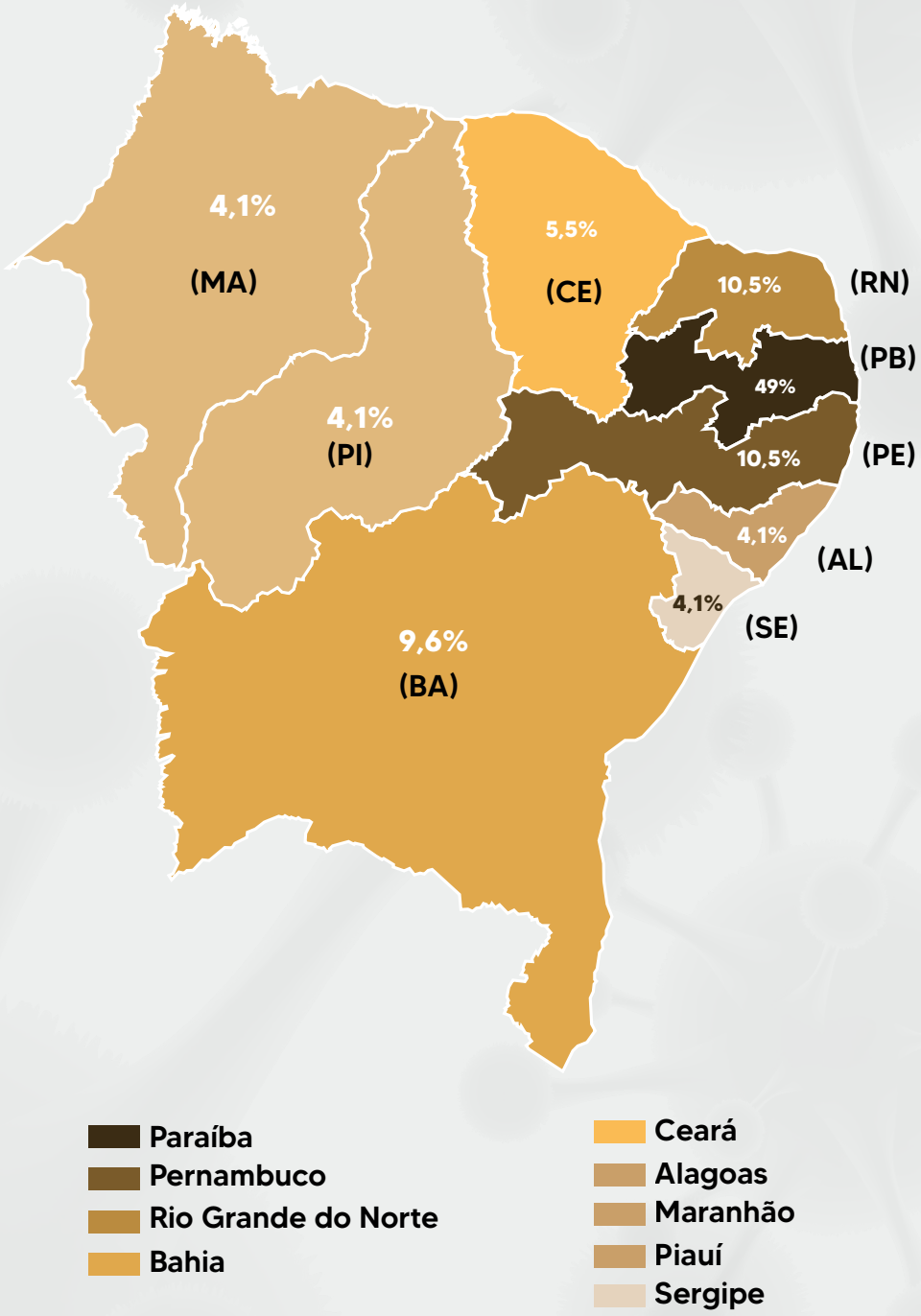


Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

Sobre o estado de atuação, obteve-se participação de profissionais dos nove estados da região Nordeste do Brasil, com maioria atuando na Paraíba (49%) [Gráfico 5]; o recorte político-espacial mais apontado como lócus de atuação foi a região metropolitana (64,2%) [Gráfico 6] e a maioria dos/as profissionais recebe uma remuneração entre um e seis salários mínimos (89,9%) [Gráfico 7]. O perfil também indica que esses/as trabalhadores/as, em sua maioria: são a principal renda da casa (54,6%) [Gráfico 8], não possuem outra atividade remunerada (65,6%) [Gráfico 9], têm cursos de pós-graduação (61,4%) [Gráfico 10] e não têm filhos (46,8%); como pode ser observado no Gráfico 11.



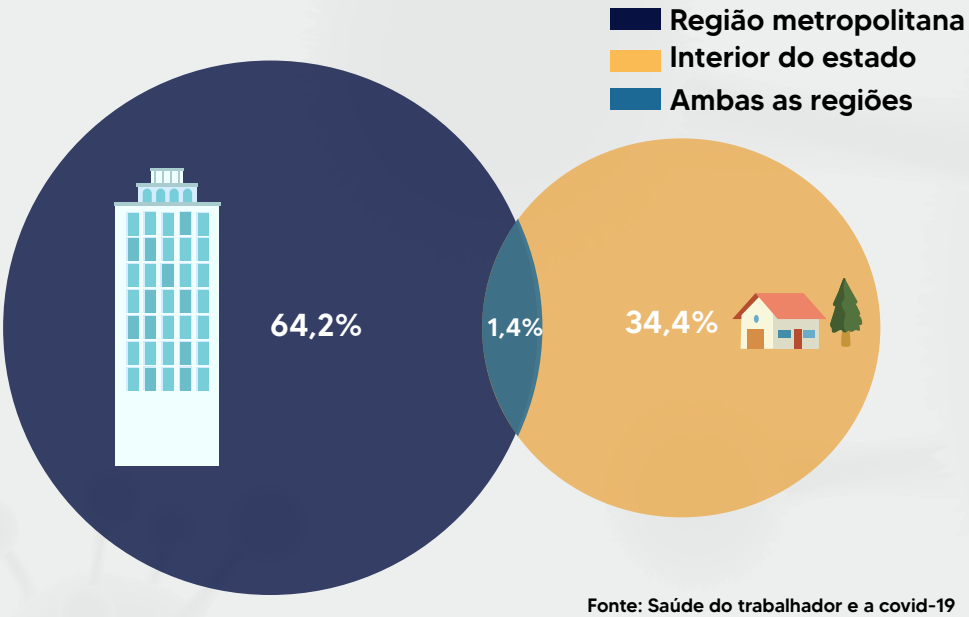
Gráfico 5. Estado de atuação no enfrentamento da covid-19



Obs.: 1,4% dos participantes declaram desempenhar atividades em mais de um estado nordestino

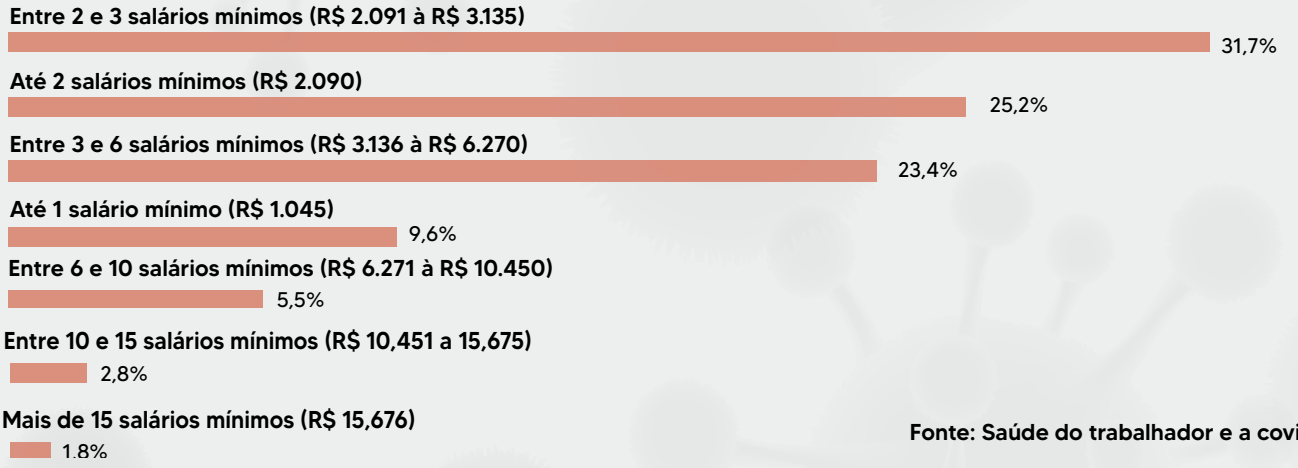
Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

Gráfico 6. Região de atuação no enfrentamento da covid-19



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

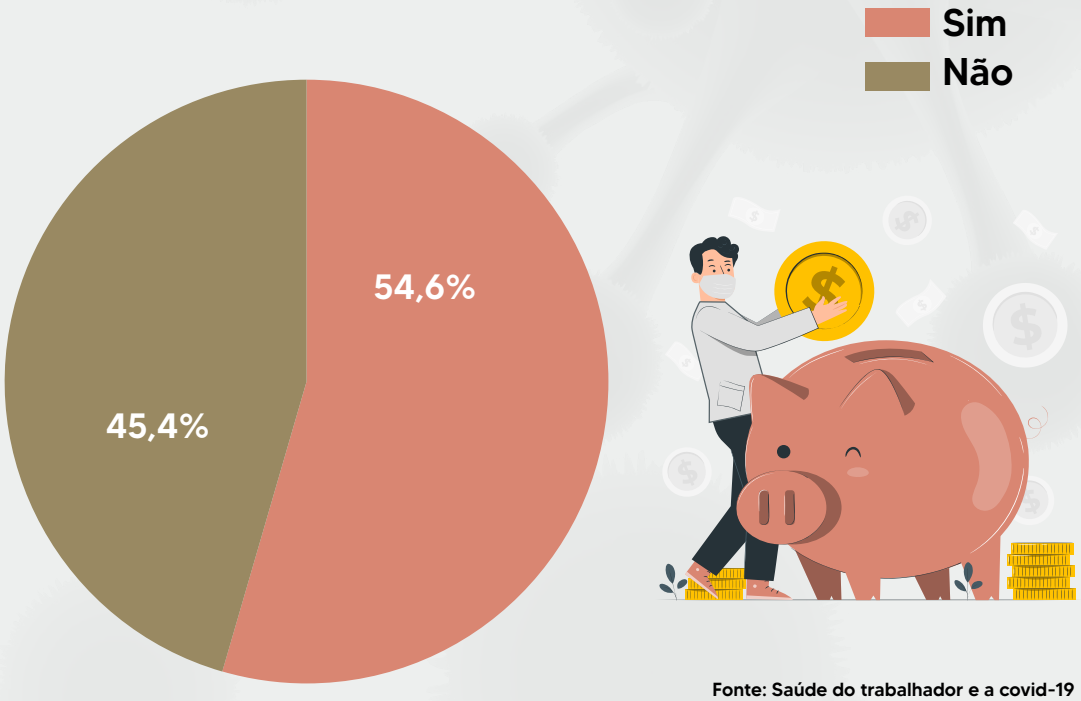
Gráfico 7. Renda líquida do/a trabalhador/a da saúde



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

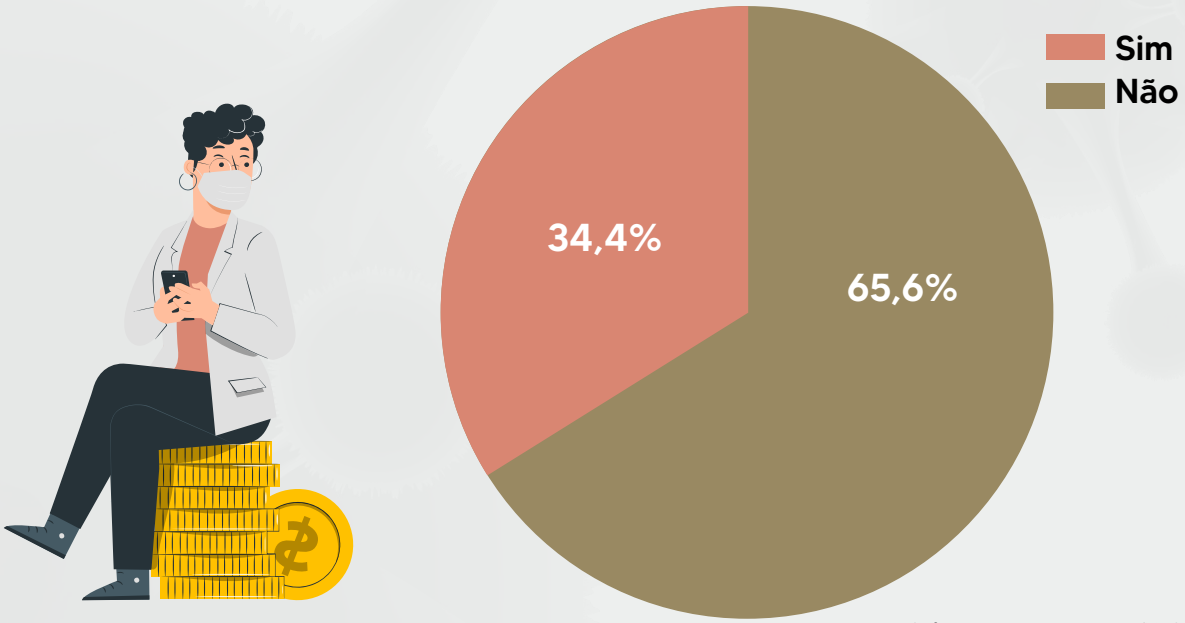


Gráfico 8. Renda do/a trabalhador/a da saúde é a principal da casa?



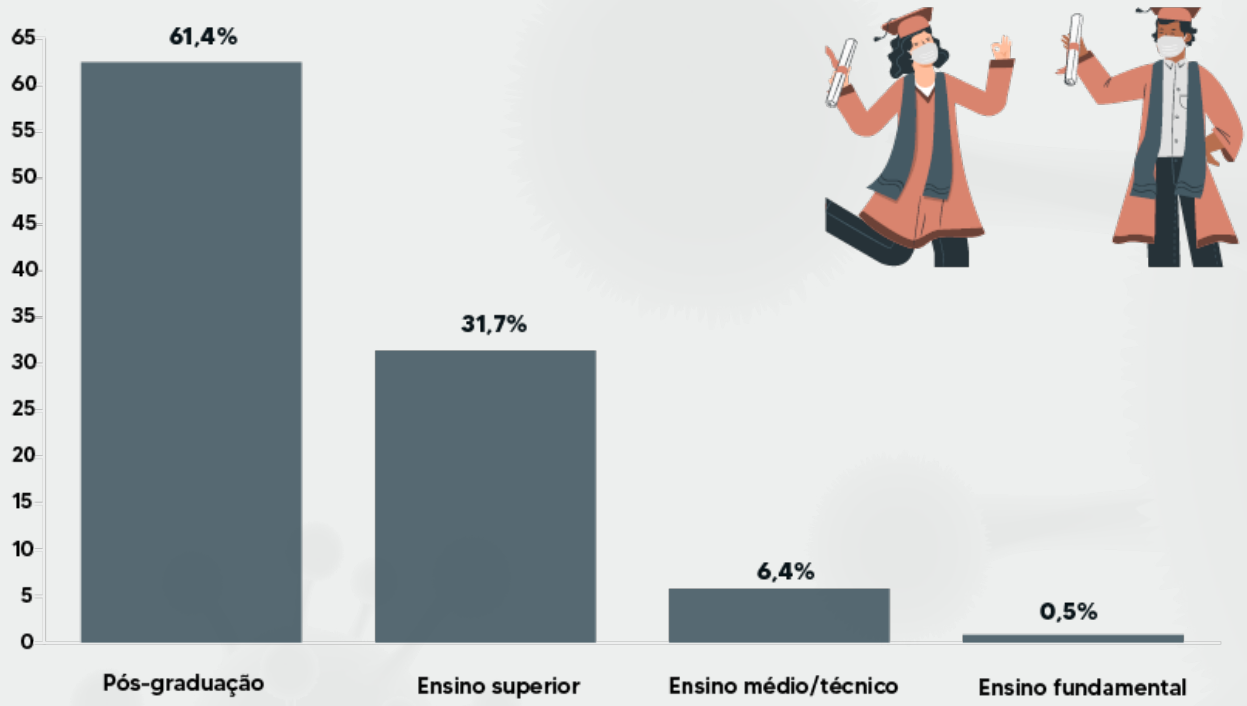
Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

Gráfico 9. O/a trabalhador/a da saúde possui outra atividade remunerada?



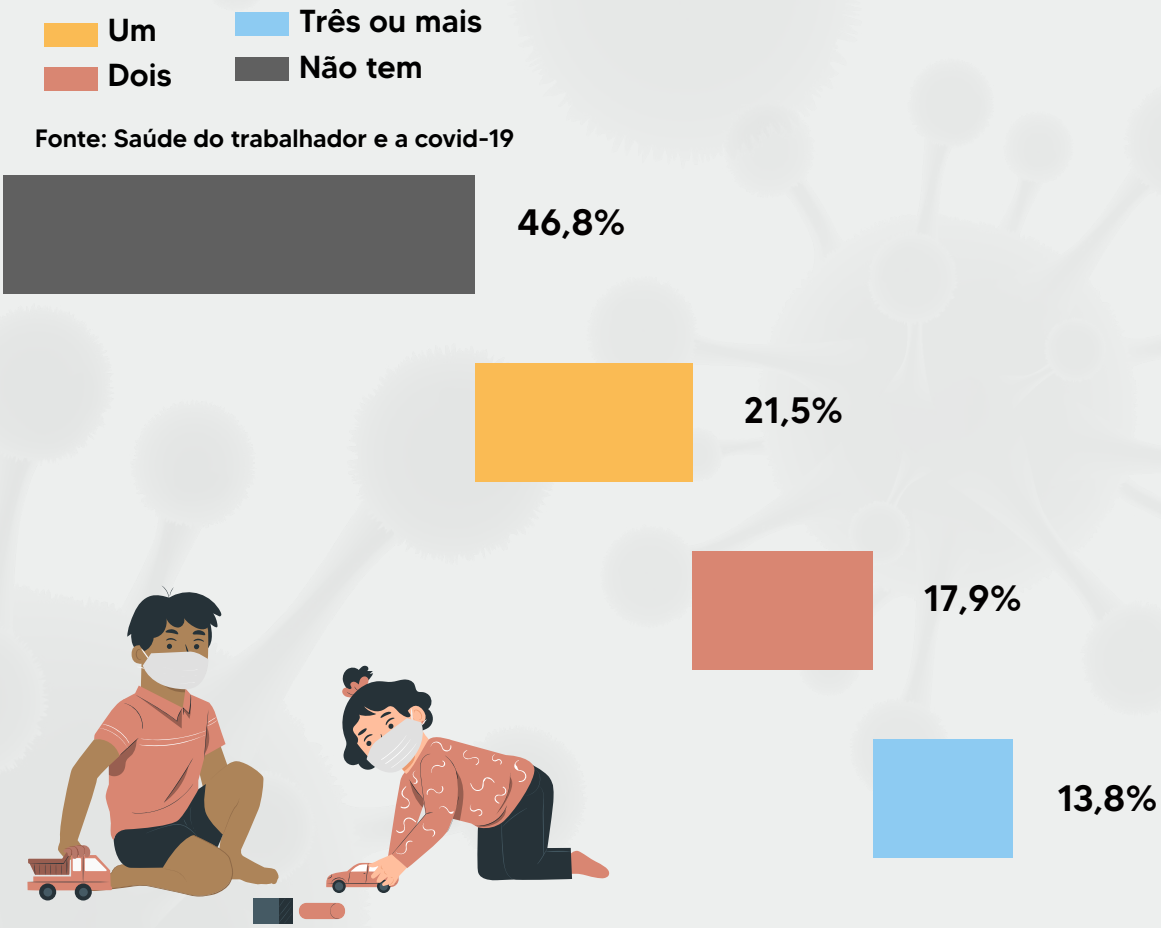
Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

Gráfico 10. Escolaridade



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

Gráfico 11. Quantidade de filhos



COMPORTAMENTO DOS/AS TRABALHADORES/AS DA SAÚDE EM RELAÇÃO AOS AMIGOS E FAMILIARES DURANTE A PANDEMIA

Quanto às pessoas com quem residem, os/as profissionais indicaram diversas configurações, como pode ser visto no Gráfico 12, bem como um perfil onde 53,2% moram com pessoas do grupo de risco e 46,8% não [Gráfico 13]. Quanto a comportamentos de contato fora do ambiente profissional, a maioria indicou que não evitou contato com pessoas do núcleo familiar (51,8%) [Gráfico 14], provavelmente por não haver outras possibilidades de estadia, entretanto, 78,4% evitaram contato com pessoas fora do núcleo familiar próximo [Gráfico 15], indicando uma estratégia de contenção e proteção como sugerido pelos órgãos e agências reguladoras de saúde e políticas públicas. A maioria dos/as trabalhadores/as (56%) afirmou que pessoas não evitaram contato com eles por causa de sua função no enfrentamento da pandemia [Gráfico 16], entretanto, 96,8% declararam que precisaram evitar contato com familiares e amigos [Gráfico 17].

Gráfico 12. Distribuição dos dados quanto à configuração residencial*

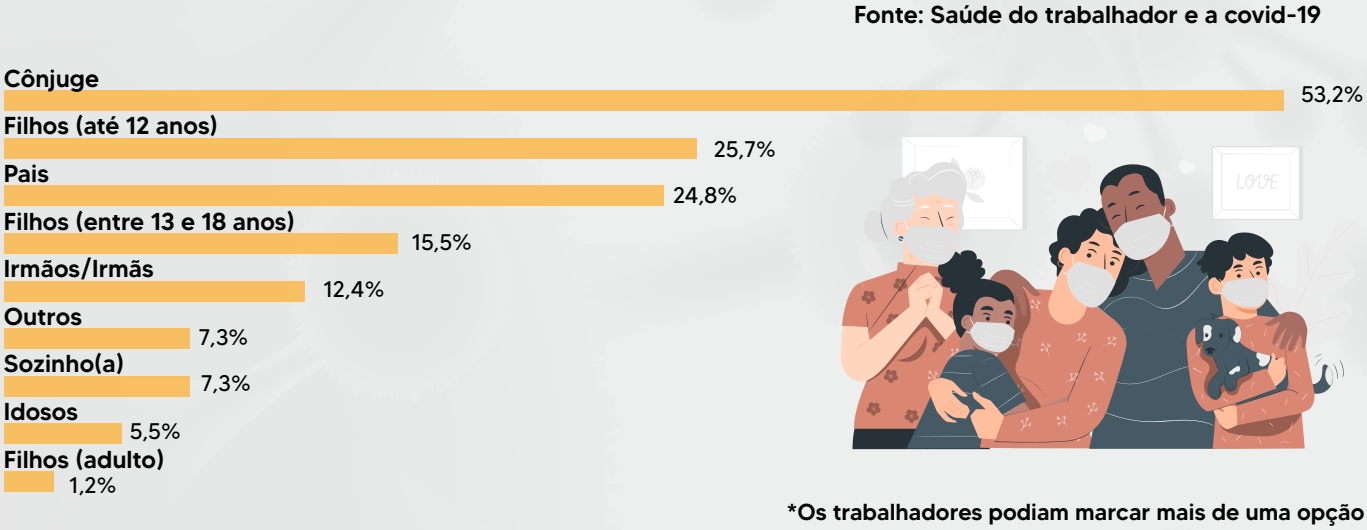


Gráfico 13. O/a trabalhador/a da saúde reside com pessoas que fazem parte do grupo de risco da covid-19?

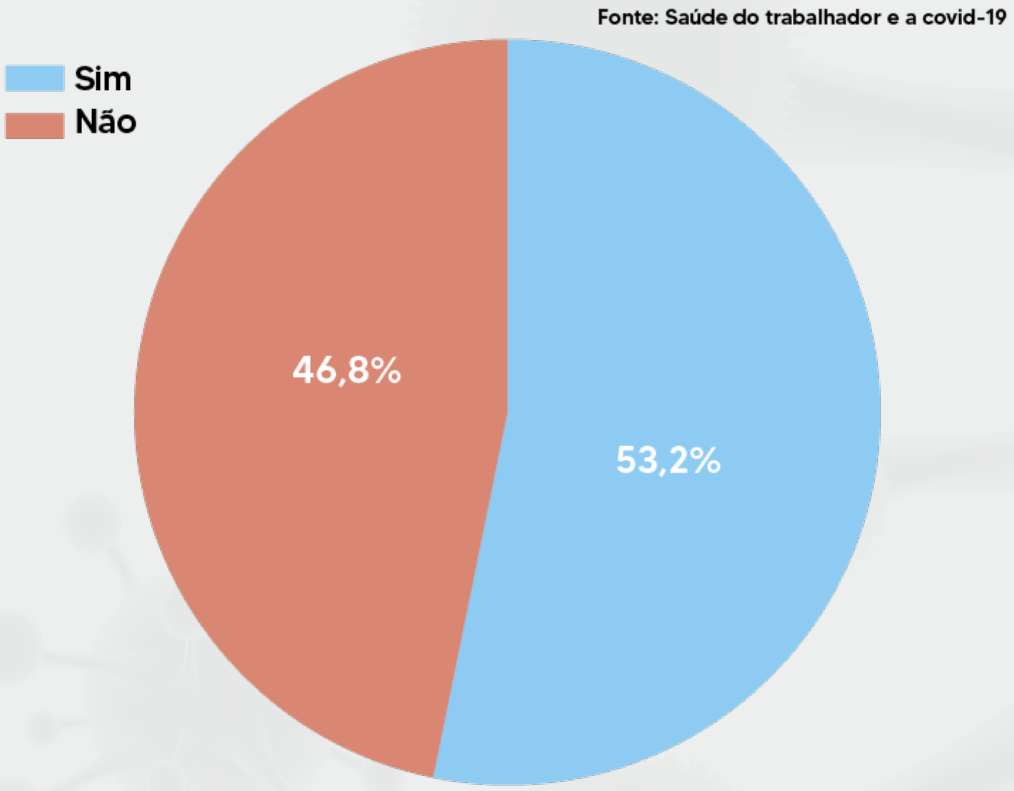


Gráfico 14. O/a trabalhador/a da saúde evitou contato com familiares do núcleo familiar?

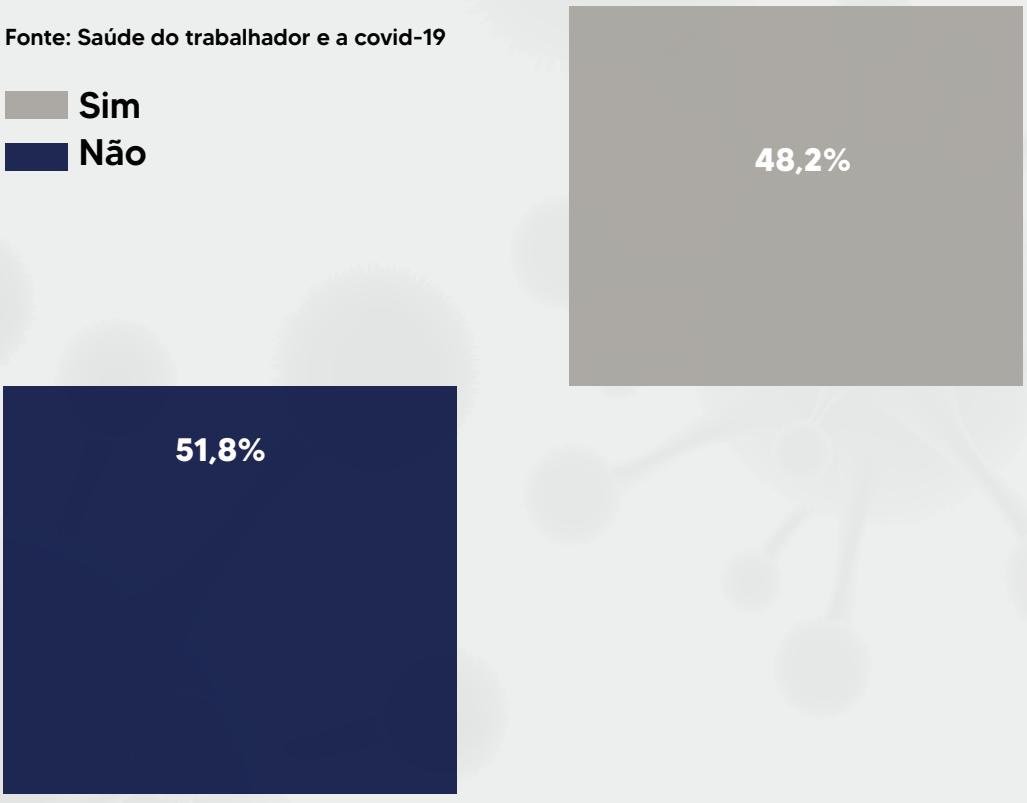


Gráfico 15. O/a trabalhador/a da saúde evitou contato com familiares fora do núcleo familiar?

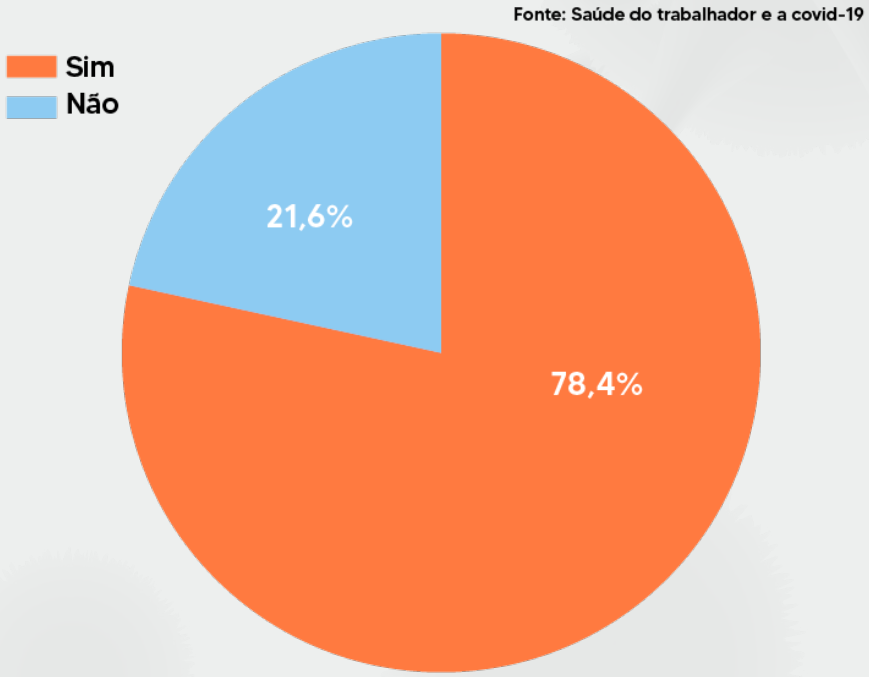


Gráfico 16. Algumas pessoas evitaram ter contato com o/a trabalhador/a da saúde por causa do trabalho na área?

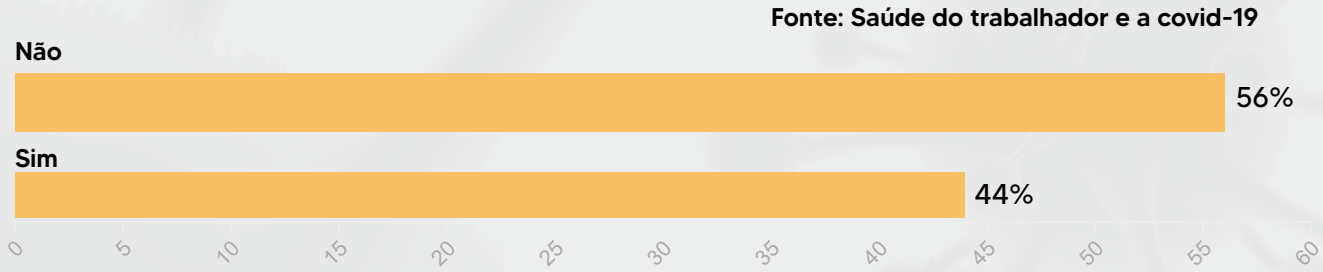
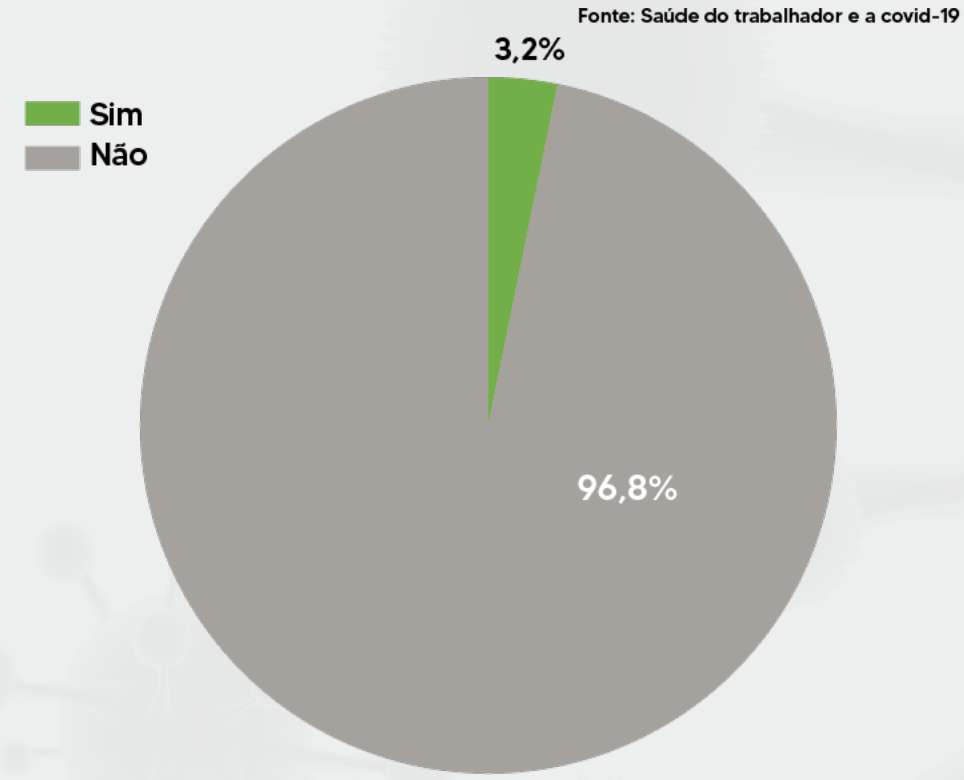




Gráfico 17. O/a trabalhador/a da saúde não precisou evitar contato com amigos e familiares





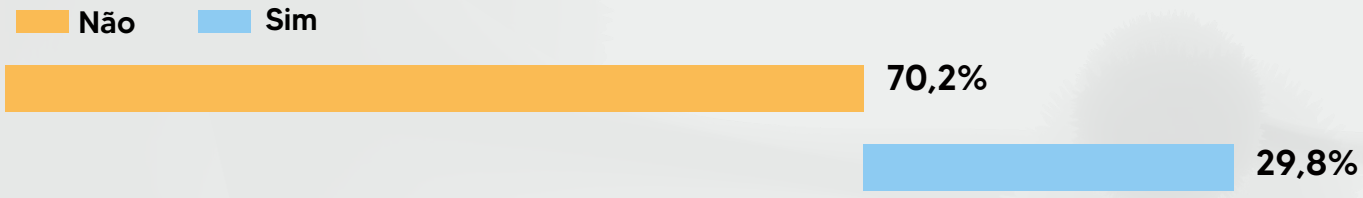
DADOS RELACIONADOS À CONTAMINAÇÃO DE TRABALHADORES/AS DA SAÚDE COM O NOVO CORONAVÍRUS

Como trabalhadores da saúde na linha de frente do enfrentamento da pandemia da covid-19, a exposição ao vírus aumenta devido ao ambiente laboral. Do total de participantes do estudo, 29,8% afirmaram ter sido contaminados pelo Sars-CoV-2 (novo coronavírus), conforme vemos no Gráfico 18. Daqueles que se contaminaram, 86,2% acreditam ter sido infectados no trabalho [Gráfico 19] e 84,7% apresentaram sintomas [Gráfico 20].

Em relação à recuperação, 9,2 % daqueles que se contaminaram não se afastaram do trabalho; enquanto 81,5% se afastaram e fizeram o tratamento em casa; 7,7% se afastaram, precisando de hospitalização em leito comum; e 1,6% se afastaram e receberam tratamento em UTI [Gráfico 21]. Ainda entre os que indicaram contaminação pelo novo coronavírus, 53,8% declararam que outras pessoas da família foram infectadas [Gráfico 22].



Gráfico 18. O/a trabalhador/a da saúde foi contaminado pelo Sars-CoV-2 (novo coronavírus).



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

Gráfico 19. O/a trabalhador/a da saúde acredita ter se contaminado no trabalho.

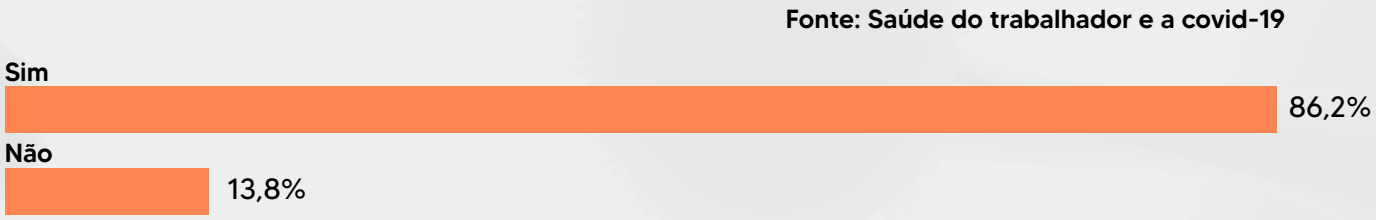


Gráfico 20. O/a trabalhador/a da saúde apresentou sintomas.

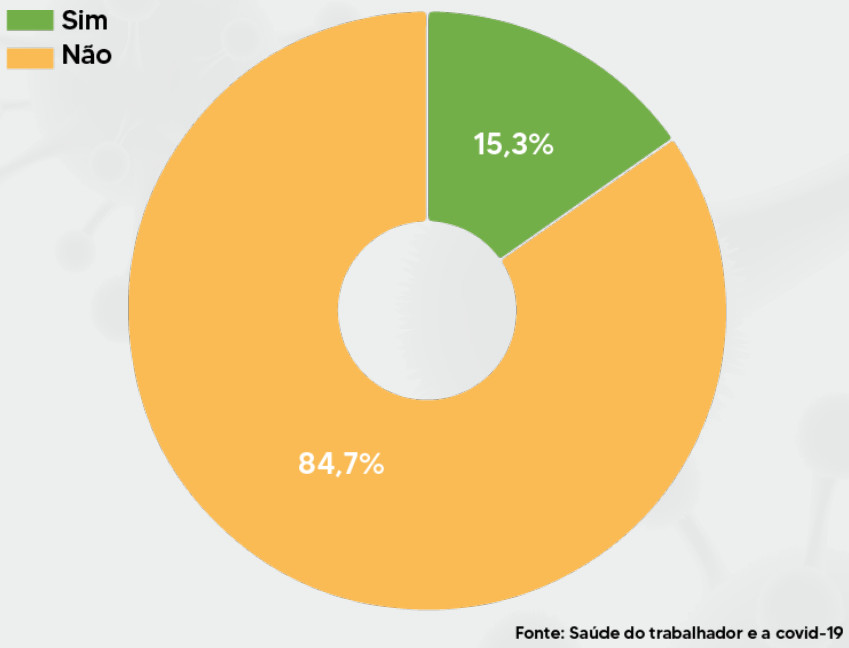


Gráfico 21. O/a trabalhador/a da saúde afastou-se do trabalho para se recuperar.

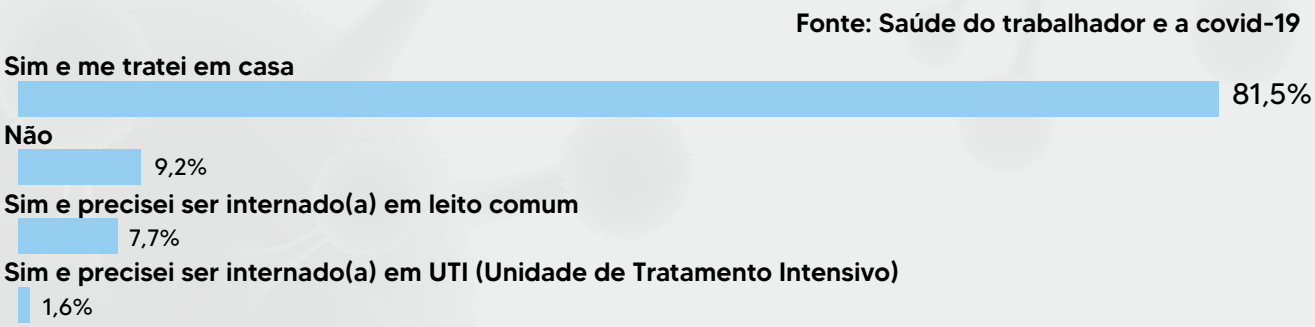
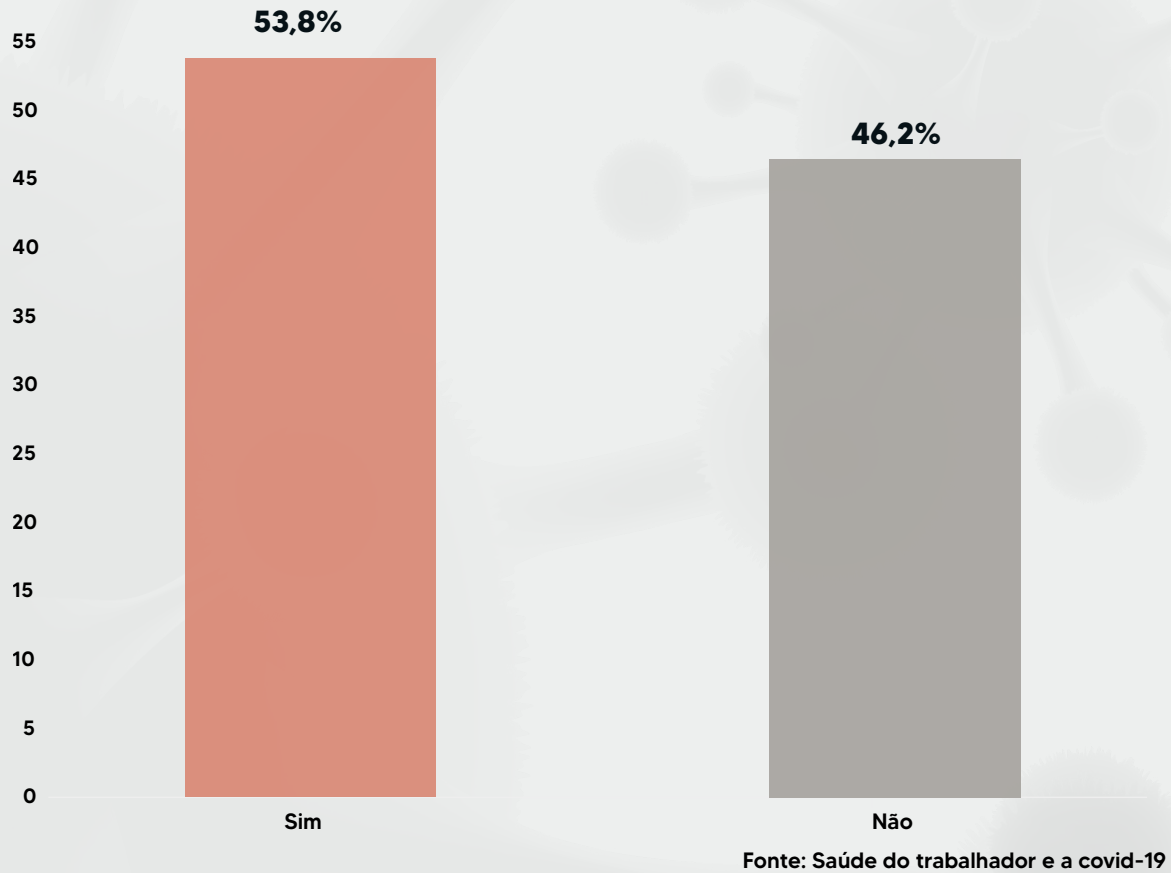




Gráfico 22. Outras pessoas da família do/a trabalhador/a da saúde foram infectadas.

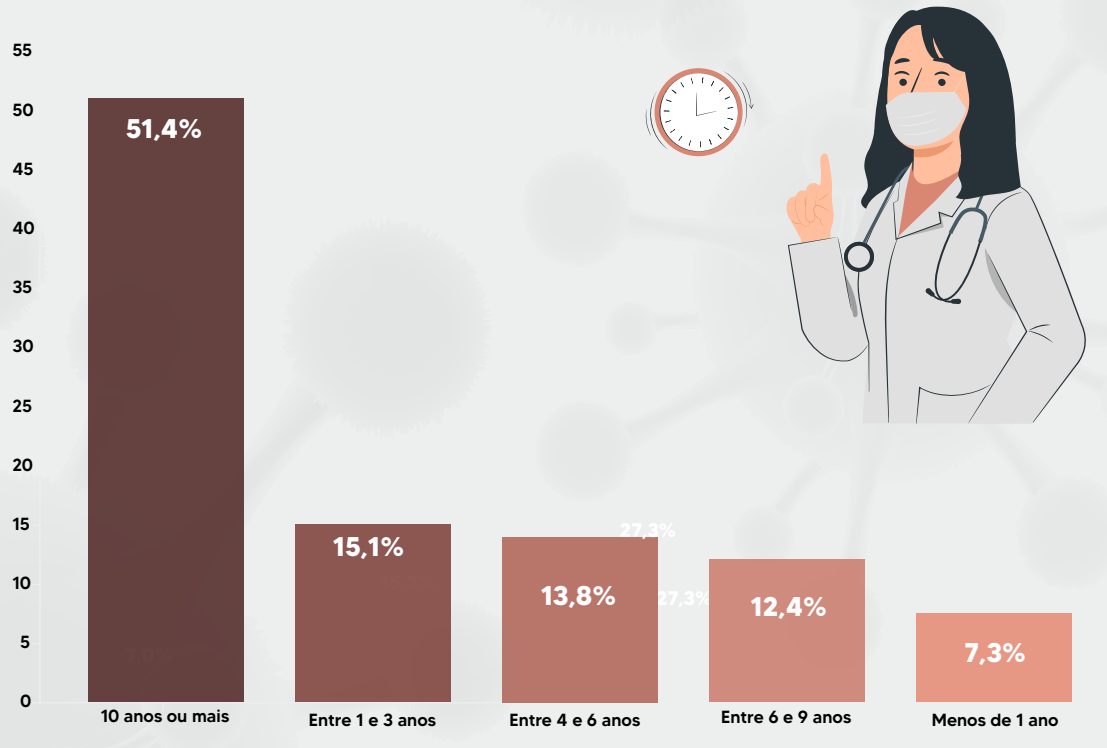


Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS QUANTO À PROFISSÃO E AO LOCAL DE TRABALHO

Quanto ao perfil laboral, a maioria dos/as profissionais está formada há dez anos ou mais (51,4%) [Gráfico 23] e trabalha em hospitais públicos, de campanha ou filantrópicos (66,1%) [Gráfico 24]. Cabe destacar que 26% da amostra trabalha em mais de uma instituição, outra prática comum entre os/as profissionais da saúde, que pode contribuir para maiores jornadas de trabalho e, consequentemente, maior exposição à possibilidade de contágio. Quanto ao vínculo empregatício, 44,5% são efetivos, mas 18,6% dos respondentes indicaram possuir mais de um vínculo [Gráfico 25]; 64,2% apresentam estar num regime entre 21 a 40 horas semanais de trabalho [Gráfico 26] e 51,8% já exerceram trabalho anterior com doenças infecciosas [Gráfico 27]; sendo que apenas 19,3% foram contratados exclusivamente para o contexto da pandemia [Gráfico 28].

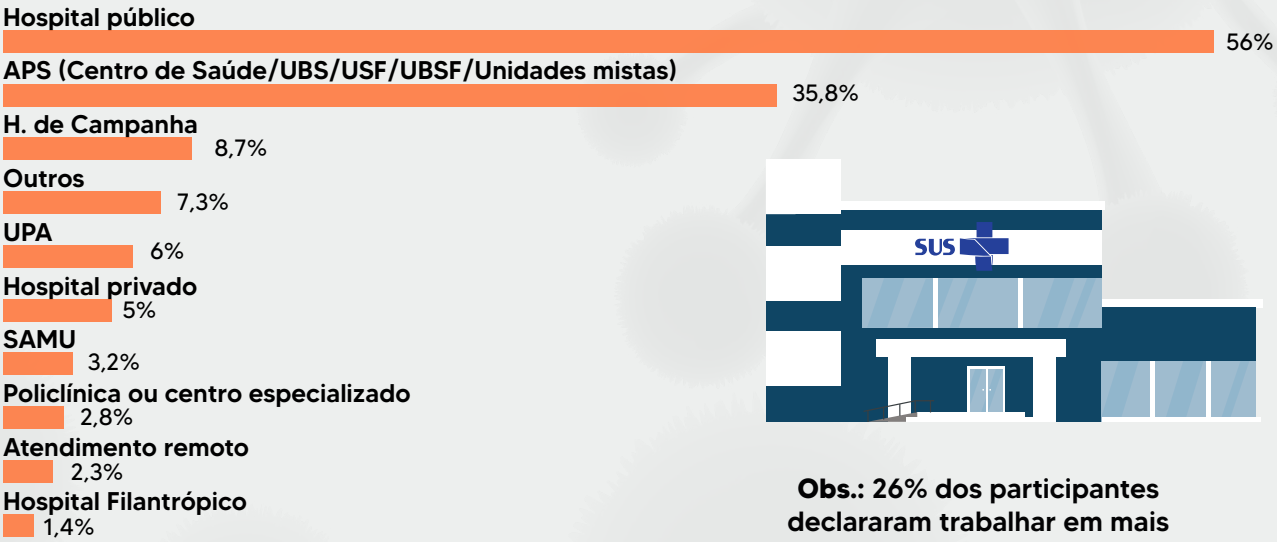
Gráfico 23. Tempo de formação



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

Gráfico 24. Instituição de trabalho*

Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19 ***Os trabalhadores podiam marcar mais de uma opção**



Obs.: 26% dos participantes declararam trabalhar em mais de uma instituição

Gráfico 25. Tipo de vínculo empregatício*

***Os trabalhadores podiam marcar mais de uma opção // Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19**



Obs.: 18,6% dos participantes declararam possuir mais de um vínculo empregatício

Gráfico 26. Jornada semanal de trabalho

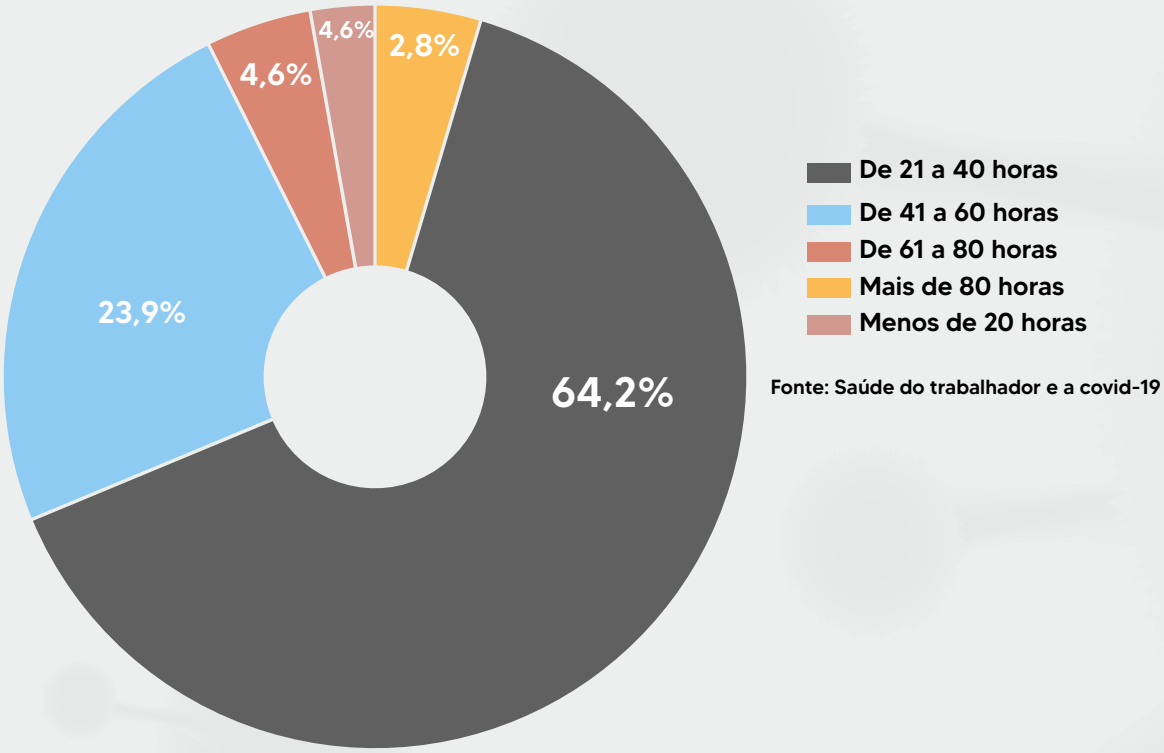


Gráfico 27. O/a trabalhador/a da saúde exerceu trabalho anterior com doenças infecciosas

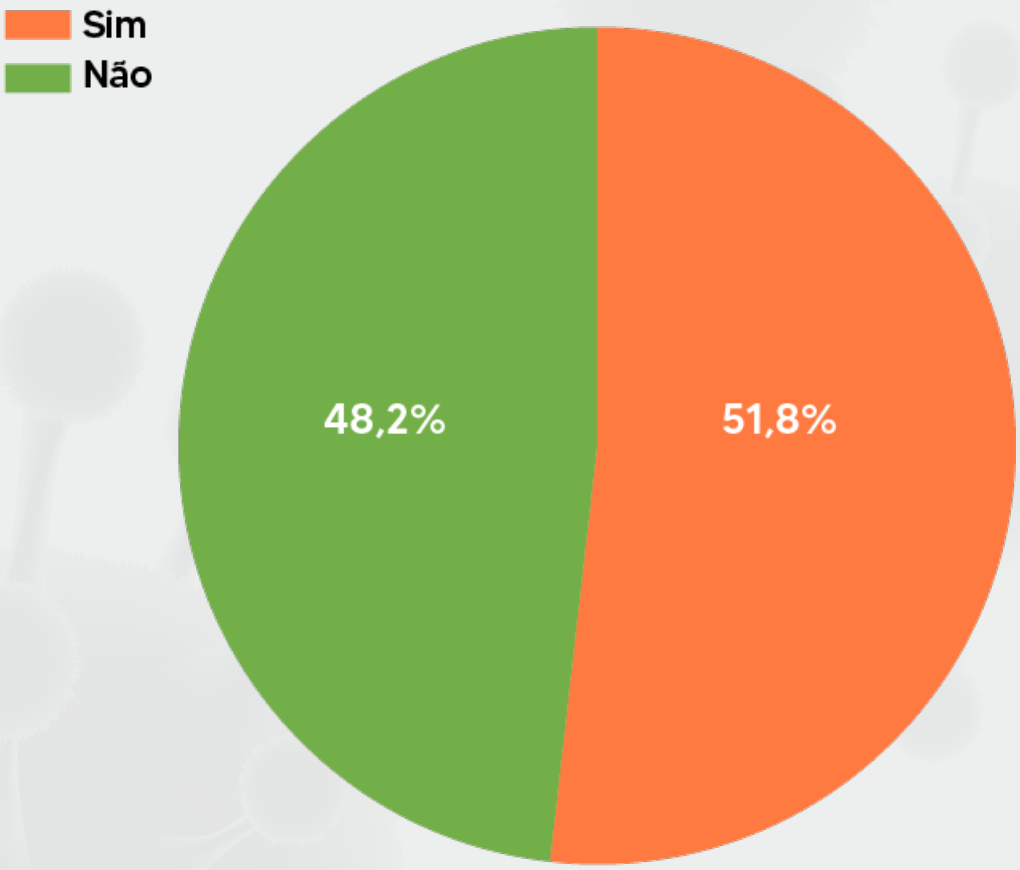
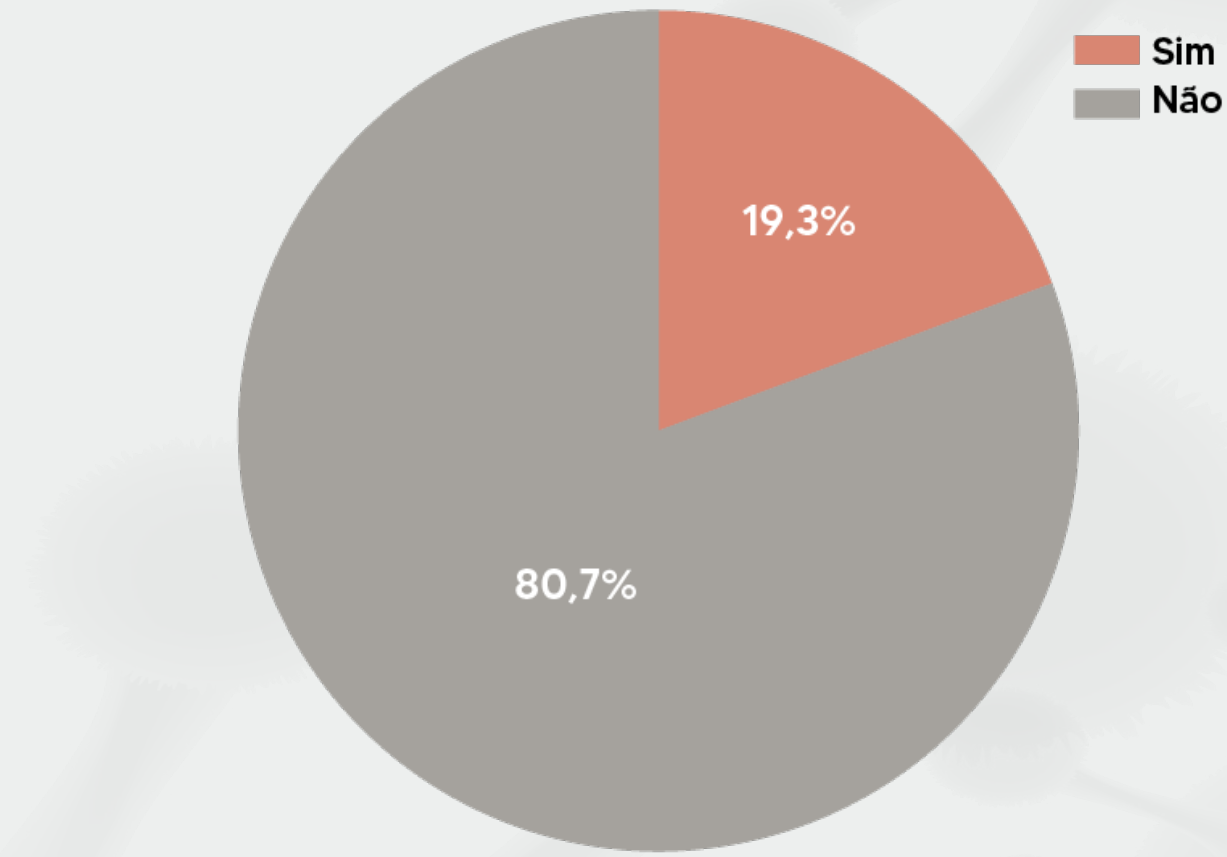


Gráfico 28. Contrato exclusivo covid-19

Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19





DISTRIBUIÇÃO DOS DADOS QUANTO À FORMAÇÃO PARA O COMBATE À PANDEMIA

Quanto à formação específica para combate à pandemia, 48,6% da amostra receberam treinamento específico [Gráfico 29], e destes, 51% não o consideraram suficiente [Gráfico 30]. Dos que receberam treinamento, as vias de acesso e conteúdo foram várias, como pode ser observado nos Gráficos 31 e 32.

Gráfico 29. O/a trabalhador/a da saúde recebeu treinamento para atuar no combate à covid-19

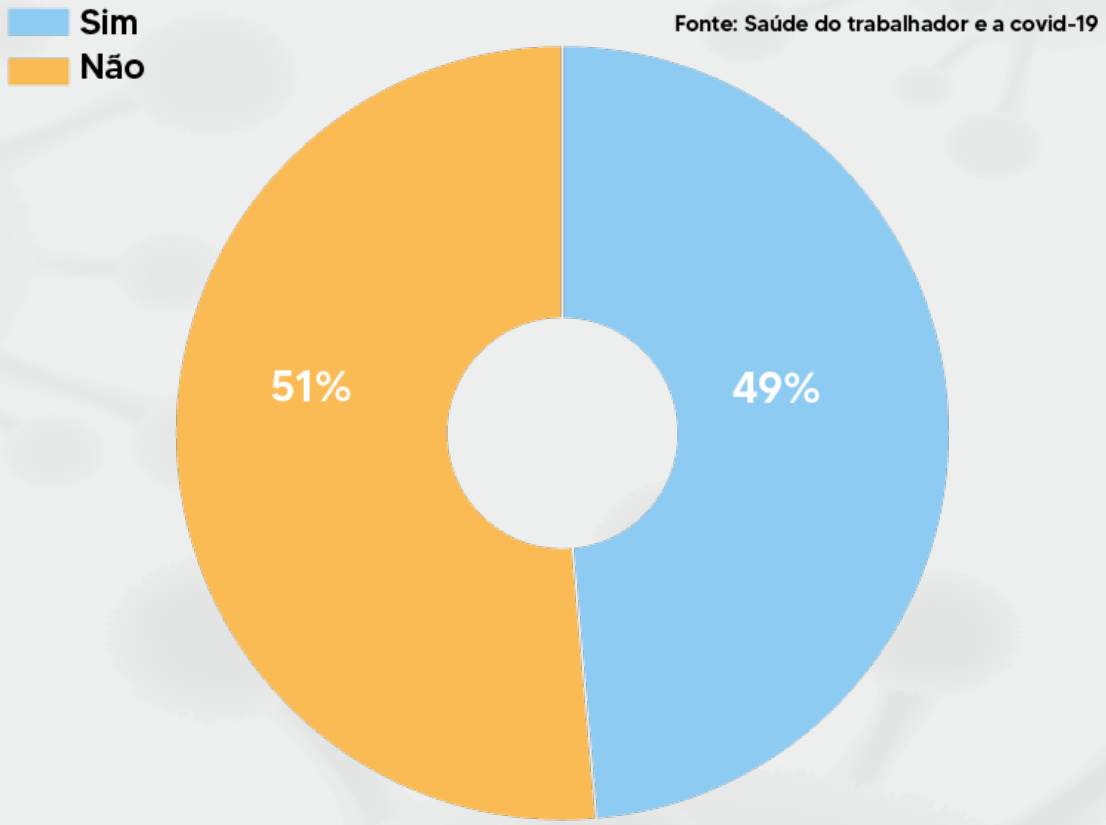
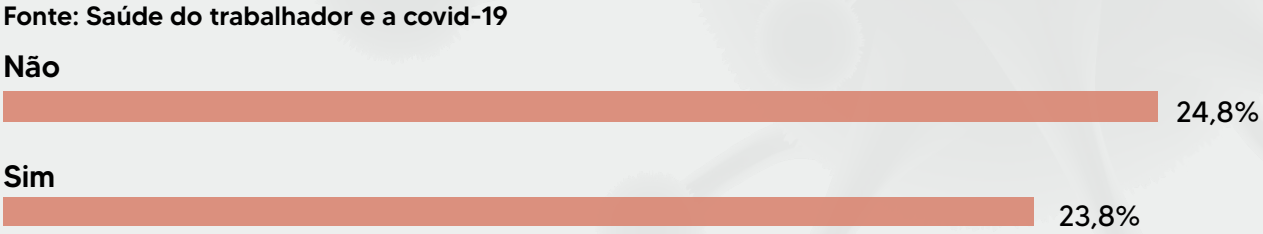
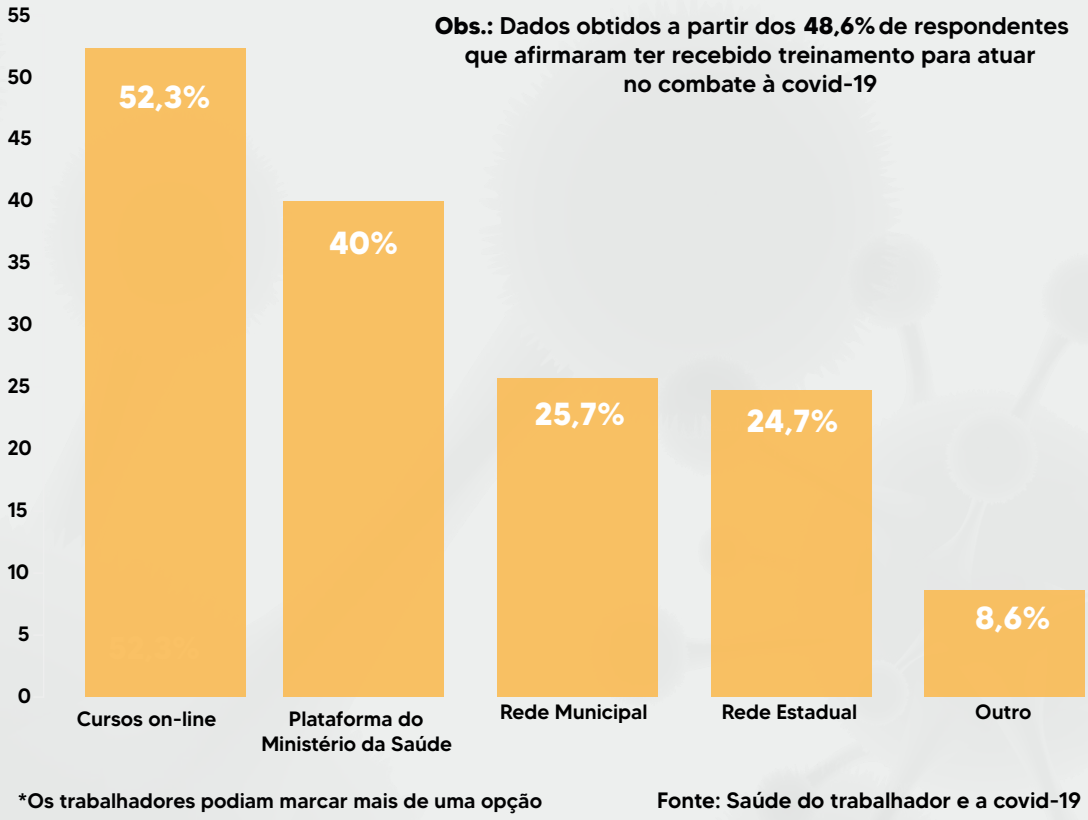


Gráfico 30. O/a trabalhador/a da saúde considera que o treinamento recebido foi suficiente



Obs.: Dados obtidos a partir dos **48,6%** de respondentes que afirmaram ter recebido treinamento para atuar no combate à covid-19

Gráfico 31. Via de acesso ao treinamento*

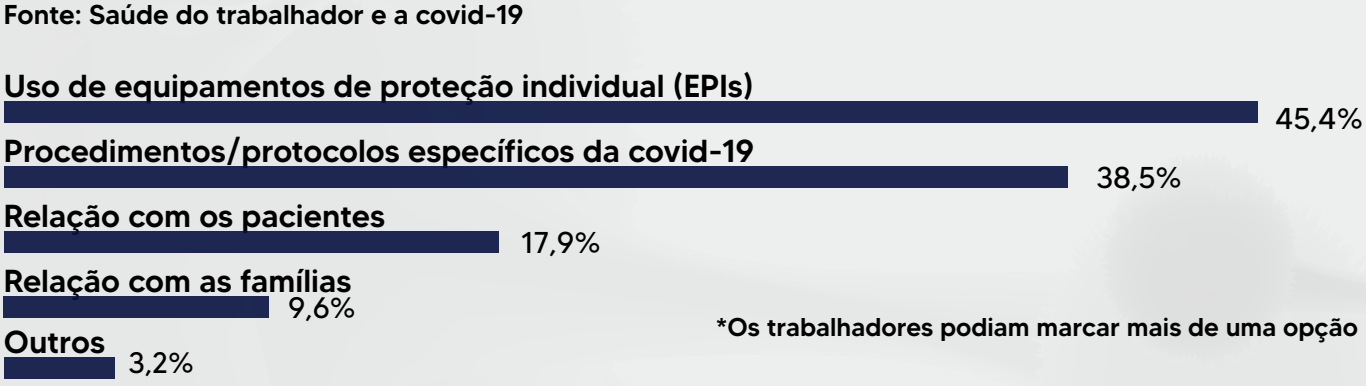


Obs.: Dados obtidos a partir dos **48,6%** de respondentes que afirmaram ter recebido treinamento para atuar no combate à covid-19

*Os trabalhadores podiam marcar mais de uma opção

Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

Gráfico 32. Conteúdo do treinamento*



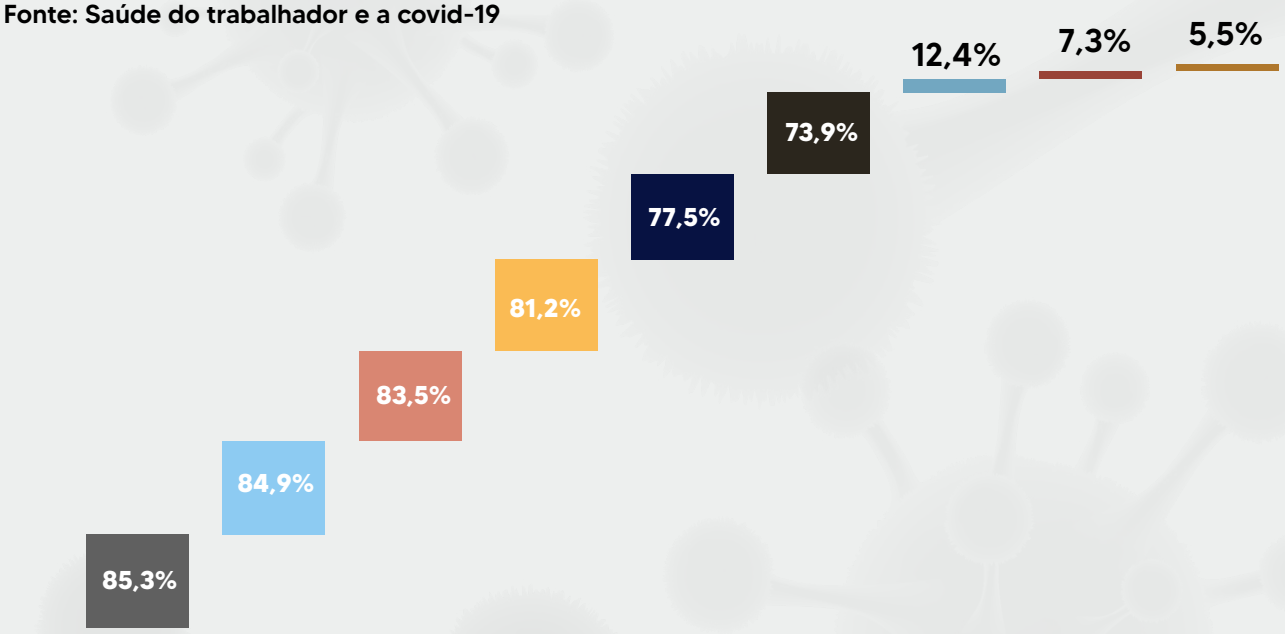
*Os trabalhadores podiam marcar mais de uma opção

DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)

Quanto ao recebimento dos equipamentos de proteção individual (EPIs), o Gráfico 33 indica os itens recebidos e os Gráficos 34 e 35 apontam as avaliações dos/as trabalhadores/as sobre a suficiência e manutenção dos equipamentos, havendo uma predominância de avaliações negativas sobre a manutenção dos EPI.

Gráfico 33. Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) disponíveis*

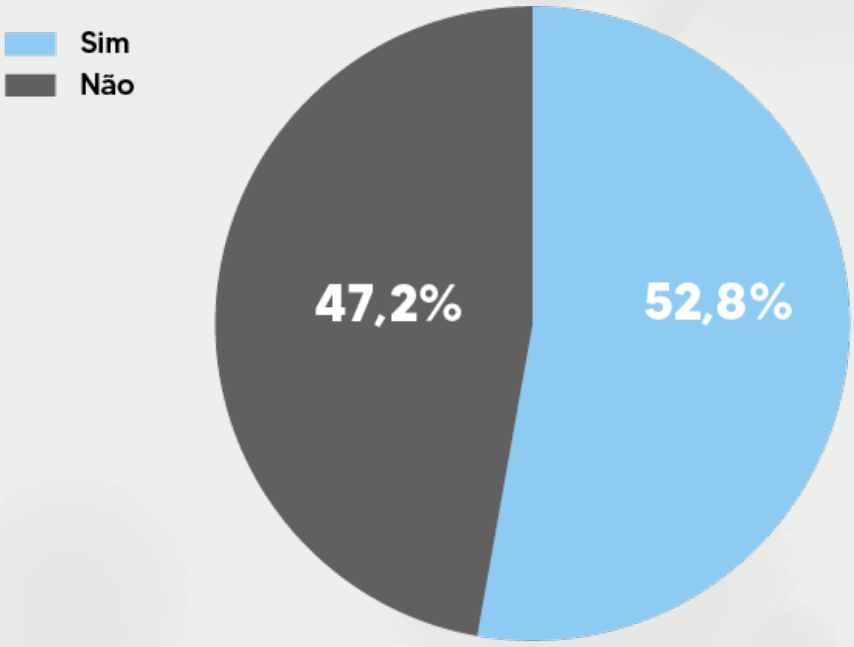
Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19



- Máscara cirúrgica
- Luvas de procedimento
- Gorro/touca/propé descartável
- Capote/avental
- Máscara N95/PFF2
- Proteção ocular/facial
- Necessário providenciar os próprios EPIs
- Necessário improvisar os próprios EPIs
- Outro

*Os trabalhadores podiam marcar mais de uma opção

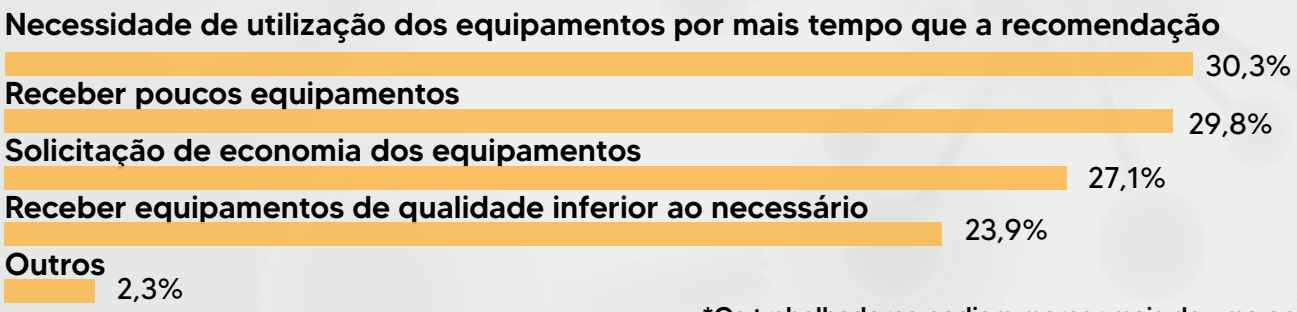
Gráfico 34. O/a trabalhador/a da saúde avalia se os equipamentos recebidos são suficientes



Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19

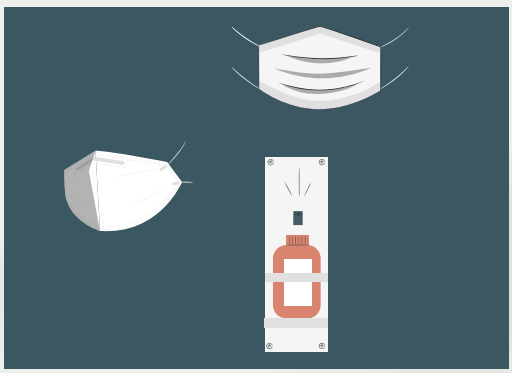
Gráfico 35. Características das condições insuficientes de manutenção dos EPIs*

Fonte: Saúde do trabalhador e a covid-19



*Os trabalhadores podiam marcar mais de uma opção





DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES OFERECIDAS PELAS INSTITUIÇÕES DE TRABALHO VOLTADAS À SAÚDE MENTAL

A maioria dos/as profissionais (71,6%) indicou que o local onde trabalha não ofereceu ações específicas de cuidado à sua saúde mental, conforme vemos no Gráfico 36. Dentre os 28,4% que afirmaram ter tido essas ações, é possível observar que também houve diversidade de estratégias, predominando a escuta individual (70,5%), como demonstra o Gráfico 37.

Gráfico 36. A instituição de trabalho ofereceu ações específicas de cuidado à saúde mental

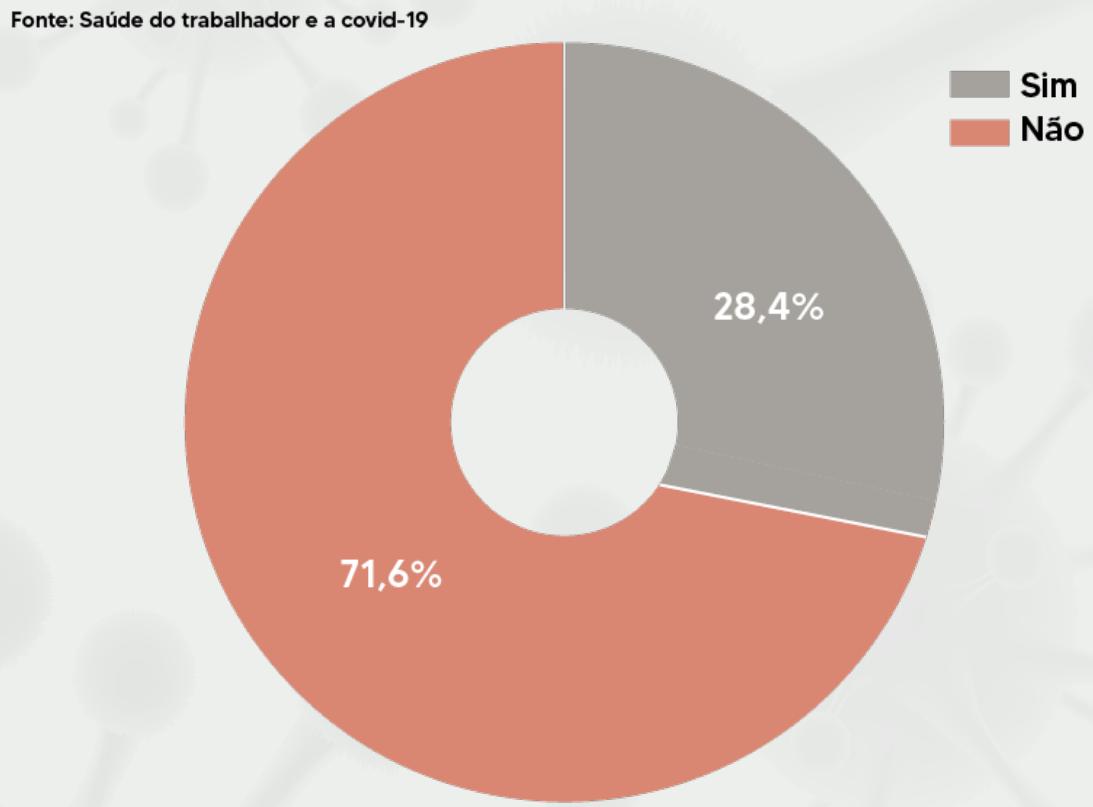
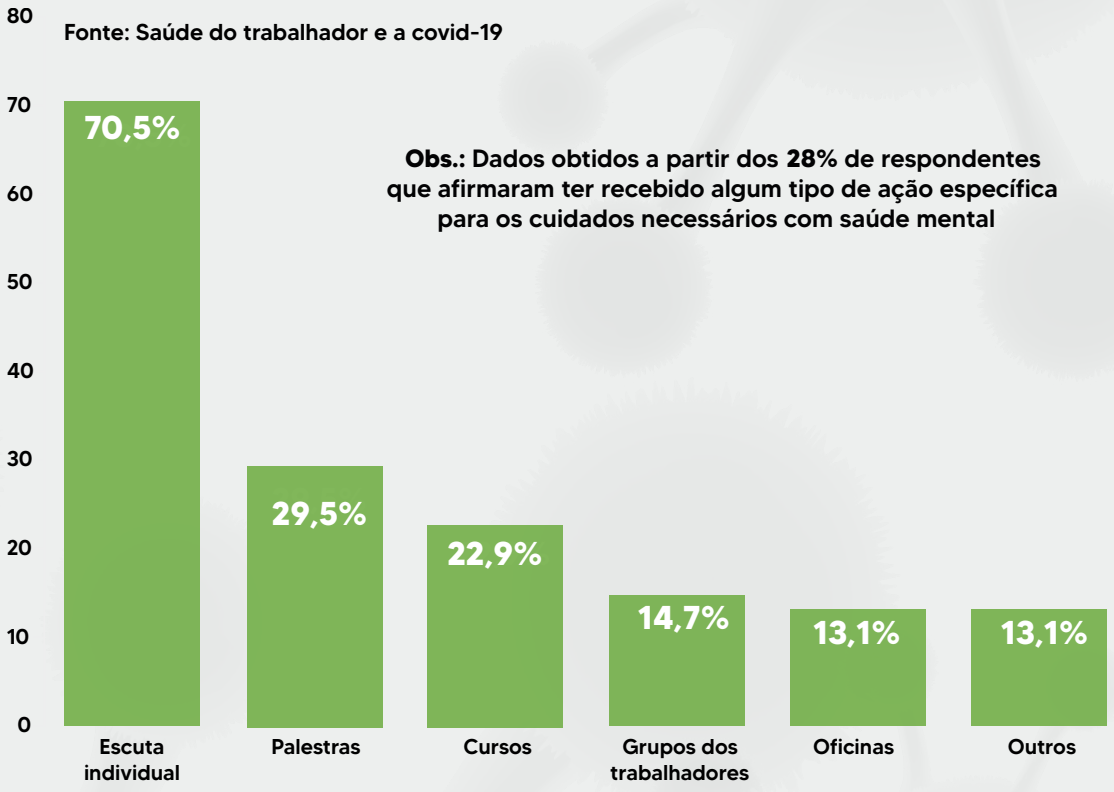


Gráfico 37. Quantitativo de ações específicas voltadas para a saúde mental dos/as trabalhadores/as (tipos de ações)*



Obs.: Dados obtidos a partir dos **28%** de respondentes que afirmaram ter recebido algum tipo de ação específica para os cuidados necessários com saúde mental

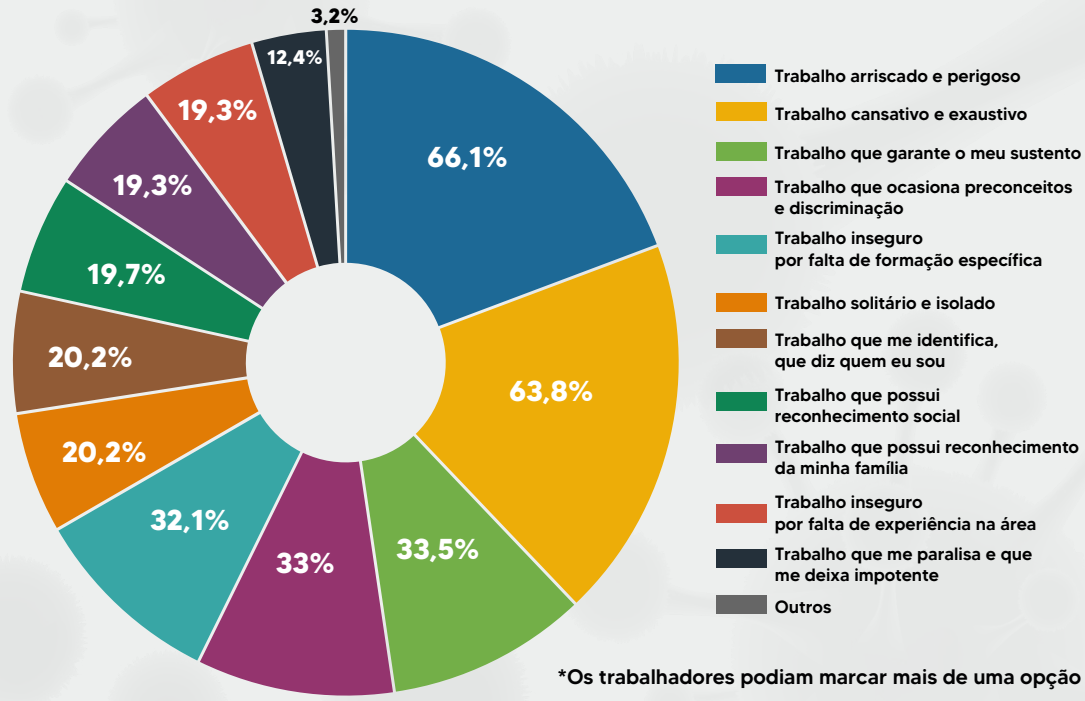
*Os trabalhadores podiam marcar mais de uma opção



SENTIDO DO TRABALHO

Em relação ao sentido do trabalho, o Gráfico 38 apresenta as impressões dos/as trabalhadores/as da saúde sobre o que a atividade que exercem representa. Podendo escolher mais de uma opção, dentre várias respostas possíveis, as cinco com maiores percentuais foram as seguintes: 66,1% consideraram o trabalho arriscado e perigoso; 63,8%, cansativo e exaustivo; 33,5% mencionaram o trabalho como o que lhes garante o sustento; 33% destacaram que o trabalho ocasiona preconceitos e discriminação; e 32,1% veem o trabalho como inseguro por falta de formação específica.

Gráfico 38. O que o trabalho com covid-19 representa para o/a trabalhador/a da saúde*

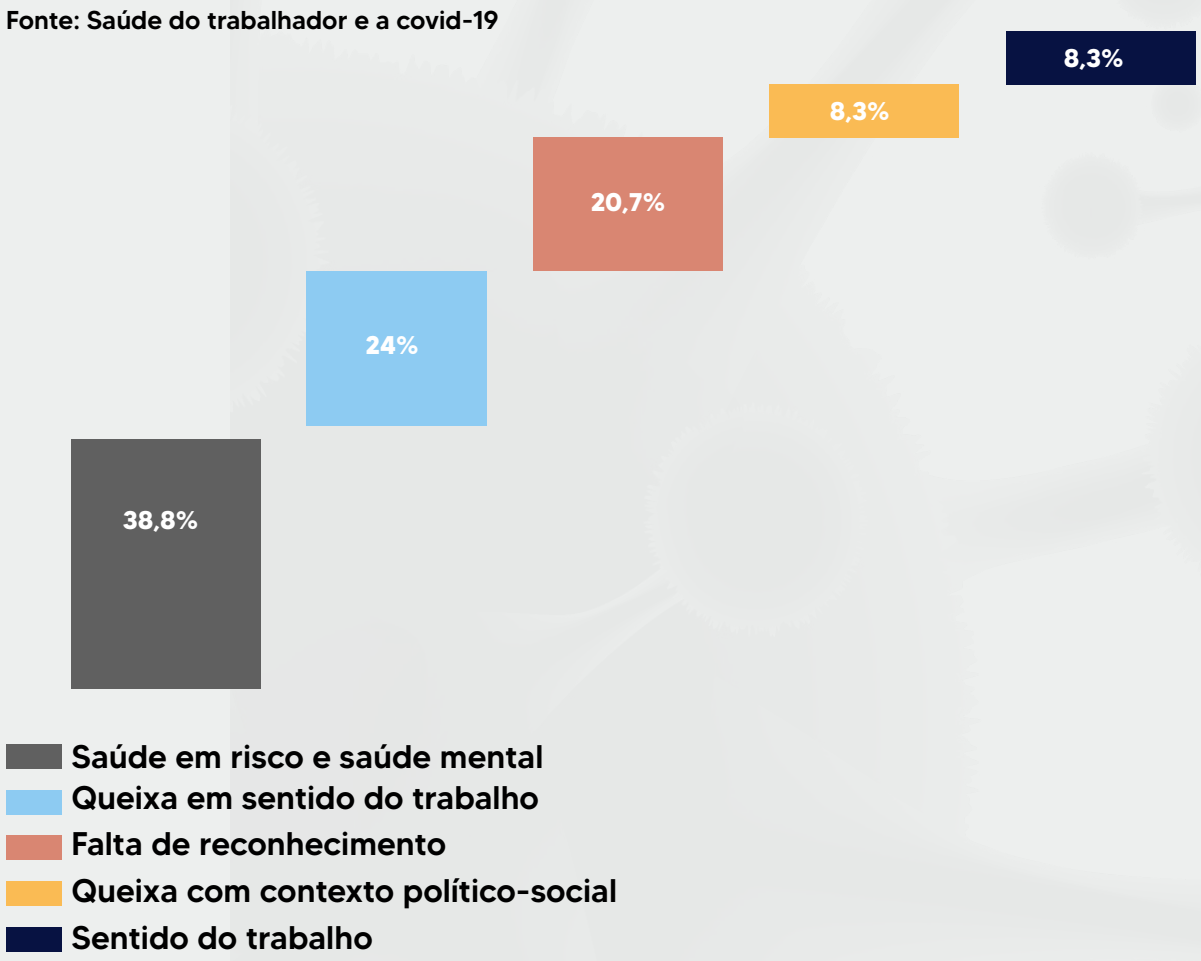


RESPOSTAS ABERTAS

Após responderem a todas as questões de múltipla escolha do questionário, diante da pergunta "Você gostaria de acrescentar algo mais sobre os desafios de trabalhar na linha de frente do combate à pandemia?", os/as trabalhadores/as participantes do estudo tinham a possibilidade de escreverem livremente, incluindo informações que considerassem importantes relacionadas ao trabalho no contexto de enfrentamento à covid-19.

A partir das respostas abertas coletadas, o conteúdo foi analisado e classificado nas seguintes categorias temáticas: saúde em risco e saúde mental (47 contribuições); queixa com processo de trabalho (29 contribuições); falta de reconhecimento (25 contribuições); sentido do trabalho (10 contribuições); e queixa com contexto político-social (10 contribuições).

Gráfico 39. Categorias temáticas



CATEGORIA I
SAÚDE EM RISCO E SAÚDE MENTAL

Em se tratando da categoria **Saúde em risco e saúde mental,** observou-se relatos do tipo:

> “Um dos maiores desafios foi perder dez pacientes em apenas um dia dentro da UTI. Me faltou fôlego. Em um momento do dia, eu desabei, não aguentei.”

> “A saúde mental fica em pedaços e não há nada que se possa fazer para nos sentirmos melhor.”



“Um trabalho exaustivo, que causa danos à saúde mental, emocional. Muitas vezes, nos deixa isolados, pois as pessoas se afastam de nós com medo de se contaminarem.”

“Muitos profissionais se contaminaram por só usar os EPIs se o paciente apresentasse sintomas e só depois sabiam que o paciente estava com covid. Muitos e muitos se contaminaram.”



CATEGORIA II
QUEIXA COM PROCESSO DE TRABALHO

Na categoria **Queixa com processo de trabalho**, alguns dos relatos que emergiram foram:

"Incerteza do vínculo de trabalho. Falta de condições mínimas para repouso durante o plantão. Condições físicas insuficientes para realização dos atendimentos da Psicologia. Não é garantida a remuneração nos plantões que não podemos fazer por afastamento por saúde (incluindo contaminação por covid)."

"Preconceito por parte de colegas na mesma instituição que não atuam no isolamento; falta de organização do serviço para as demandas do isolamento; mudanças de protocolo sem aviso ou capacitação da equipe; protocolo produzido por quem não vivencia a realidade do serviço; RH limitado ou inexperiente."

"Vulnerabilidades e pouca mão de obra para o enfrentamento da pandemia. Meu setor tem um déficit muito grande de funcionários e com os afastamentos por contaminação era uma sobrecarga acentuada de trabalho."

“Não é fácil trabalhar com EPIs inadequados, falta de insumos e trabalhar sabendo que você pode se contaminar e levar o vírus para seus entes queridos.”



CATEGORIA III
FALTA DE RECONHECIMENTO

Com relação à **Falta de reconhecimento**, os/as trabalhadores/as trouxeram falas significativas como:

> “Poucos trabalhadores para muita demanda. Somos tratados como máquinas que não adoecem, nem fisicamente nem mentalmente. Falta empatia com o profissional e cuidado.”

> “É um grande desafio a questão da remuneração. Não somos bem remunerados. É muito triste e decepcionante.”

> “Exigem demais e pouco reconhecem o trabalho, tanto socialmente quanto financeiramente.”

> “O nosso reconhecimento não passa da televisão. Nossos salários e condições de trabalho continuam incompatíveis com a carga de trabalho e os riscos.”

CATEGORIA IV
SENTIDO DO TRABALHO

Sobre os **Sentidos do trabalho**, eles(as) destacaram:

"A certeza de estar ajudando pessoas a enfrentarem a pandemia traz grande alívio e sensação de dever cumprido."

"Gratificante. Quando visitamos uma pessoa curada da covid-19, somos gratos a Deus pela vida."

"Foi uma experiência única, cansativa, mas proveitosa. Pudemos nos unir em prol de vidas."

"Acredito que esse é um trabalho que faz de todos os profissionais da saúde essenciais em cada área."

CATEGORIA V
QUEIXAS POLÍTICO-SOCIAIS

No que se refere às **Queixas político-sociais,** surgiram colocações como:

"Trabalho cansativo. Temos que educar as pessoas e, muitas vezes, não adianta e vemos nosso esforço em vão."

"O que dói mais é a falta de cuidados dos outros, muitas vezes, até de profissionais que trabalham na linha de frente."



“Trabalho cansativo. Temos que educar as pessoas e, muitas vezes, não adianta e vemos nosso esforço em vão.”

“Talvez, mais difícil que atender aos pacientes seja lidar com a ignorância das pessoas, quando se trata de evitar aglomerações e a vacinação. Certo comentários sobre ‘não haver comprovação de eficácia da vacina’ ou ‘não ser confiável por ser chinesa’ chegam a doer diante de tantos sacrifícios de quem lida com a covid no dia a dia. Os pesquisadores, os profissionais da linha de frente e os voluntários da vacina em todo o mundo.”



REDES SOCIAIS E CONTATOS

Instagram: @saudedotrabalhador_covid19

Facebook: fb.com/saudedotrabalhadorcovid19

E-mail: saudedotrabalhador_covid19@cchla.ufpb.br

Twitter: @saudetrab_covid

Endereço: Departamento de Psicologia – Universidade Federal da Paraíba – CCHLA – Bloco Humanístico, Campus I – Castelo Branco I, João Pessoa – PB, CEP. 58051-900



